

失。

十一、杞菊地黄丸^[11]：1例用黄连素等中西药治疗效果欠佳的患者，改用杞菊地黄丸治疗获满意疗效。方法是，早晚各服1丸，服药第2天，症状开始减轻，大便通畅，腹痛消失，大便粘液减少。再服3个月，服药期间症状全无，停药二个月后，余症复发，再用半年，全愈。随访半年未复发。作者认为杞菊地黄丸药性平淡甘和，不温不燥，全方有滋养补虚，利尿消炎，健脾胃，清热解毒之功。对慢性结肠炎，脏阴亏损，正虚邪未盛者有较好的治疗作用。

十二、阿胶^[12]：将阿胶置沸水中软化，取1.5~2.0g用手捏成椭圆形，塞入肛门内，再以肛门管（26号）送出病变部位。每日大便后上药1次，一般每日1~2枚，7~10天为1疗程。治疗2个疗程，观察200例，显效（症状消失，溃疡愈合或留有疤痕，随访1~3年无复发）118例，有效76例，无效6例，有效率97%。阿胶主要由胶原及部分水解产物组成。它能增加机体对钙的吸收和在体内的滞留，使血钙略有增高。钙离子能降低肠粘膜血管通透性，故有镇静和消炎作用。《本草纲目》记载：“阿胶乃大肠之要药，有热毒留滞者则能疏导，无热毒留滞者，则能平安。”用阿胶塞肛治疗效显著，无副作用。

十三、锡类散^[13]：锡类散原为咽喉科要药，主治烂喉丹痧及咽喉、唇舌红肿疼痛等

证。现代药理学研究，锡类散具有消炎、收缩血管及镇静止痛等作用，有人用于治疗溃疡性结肠炎收到良好效果。用灌肠法治疗62例，结果痊愈46例，显效11例，好转4例，有效率93.3%。

结语：上述老药治疗慢性溃疡性结肠炎有其药理学基础，且疗效确切，笔者认为值得临床借鉴。

参 考 文 献

- 〔1〕安子元.甲硝唑治疗慢性溃疡性结肠炎47例分析.中华消化杂志 1989, 9(5):300.
- 〔2〕王永雁.甲氧咪胍治疗慢性溃疡性结肠炎15例.实用内科杂志 1987, 7(2):92.
- 〔3〕余世光.雷尼替丁治疗溃疡性结肠炎20例的临床观察.新医学 1989, 20(7):362.
- 〔4〕薛国萍,等.盐酸左旋咪唑治疗非特异性溃疡性结肠炎.中原医刊 1991, 6:29.
- 〔5〕王鲁湘,等.色甘酸二钠与磺胺噻唑银治疗溃疡性结肠炎25例.人民军医 1991, 4:23.
- 〔6〕白建平,等.局部注射利多卡因治疗溃疡性直肠炎.医学信息杂志 1991, 2:94.
- 〔7〕蒋林生.桂利嗪治疗慢性结肠炎68例.新药与临床 1989, 8(4):241.
- 〔8〕陈艳才,等.口服硝苯吡啶治疗溃疡性结肠炎2例.医学理论与实践 1991, 4(5):26.
- 〔9〕邹仁恕.复方头孢氨苄治疗慢性溃疡性结肠炎19例.中原医刊 1989, 16(6):9.
- 〔10〕成述冒.云南白药治疗慢性溃疡性结肠炎2例.中国肛肠病杂志 1989, 3:37.
- 〔11〕赵甲明.杞菊地黄丸治疗慢性结肠炎1列报告.中国肛肠病杂志 1986, 6(8):20.
- 〔12〕郭松河.阿胶栓治疗慢性溃疡性结肠炎.中西医结合杂志 1989, 9(8):178.
- 〔13〕袁佩英.锡类散新用治疗溃疡性结肠炎.山西中医 1987, 3(4):31.

氨茶碱的药物相互作用

河北省保定地区医院(071000) 张国存 杨树茂

氨茶碱为一常用平喘药，临床上常与其它药物合用，但由于它的治疗指数较窄，有效血药浓度范围仅为10~20μg/ml，因而它的药物相互作用就显得至关重要。

一、使氨茶碱血药浓度升高的药物

1.大环内酯类^[1~8]红霉素、麦迪霉素、螺旋霉素等均可使茶碱的清除减少，半衰期延长。其作用机理可能是增加了细胞色素P-

448失活的数量,从而便茶碱的代谢受抑。

2.氯霉素^[3、5、8]由于它的酶抑制作用而影响氨茶碱的代谢,尤其是长期应用,茶碱的治疗血药浓度不易控制,毒付作用容易发生。

3.新诺明^[2、3、8]新诺明与茶碱竞争蛋白结合部位致血中游离茶碱浓度升高,毒付反应增加。

4.氟哌酸和吡哌酸^[2、9、10]它们可抑制肝微粒体混合功能氧化酶系,显著地增加茶碱的血药浓度而使毒付反应增加。

5.喘定^[5]:氨茶碱为乙二胺复盐,喘定为丙羟茶碱,如同时应用可使血中茶碱浓度增高。

6.甲氧咪胍^[2~8]甲氧咪胍能与肝脏微粒体细胞色素P-450氧化酶相结合,产生直接的非竞争性酶抑作用,使氨茶碱依赖P-450.酶氧化代谢受阻,代谢速度变慢,显著减少茶碱清除率约30%,从而导致茶碱血药浓度增高。

7.口服避孕药^[2、6、7]二者并用可使茶碱清除率减少34%,其机理可能是酶抑作用,也不排除长期使用雌激素损伤肝脏而影响了药物代谢。

8.别嘌呤醇^[2、7、11]大剂量(600mg/天)别嘌呤醇可使茶碱清除率显著减少,其机理不仅是抑制黄嘌呤氧化酶,而且还抑制肝脏其它药酶。

二、使氨茶碱血药浓度下降的药物

1.利福平^[2、12]利福平的肝酶诱导作用加速了氨茶碱的代谢,使其血药浓度下降。

2.糖皮质激素^[5、8]可增加氨茶碱的平喘效果。最近报道与强的松并用后,茶碱的血药浓度降低,但不是生物利用度的改变,而是更快地消除。氨茶碱可导致氢化可的松效价降低,可能是氢化可的松的结构发生变化。与地塞米松配伍,外观无变化,经紫外测定,它的含量已逐渐下降,须引起注意。

3.抗癫痫药^[2~5、7]抗癫痫药为药酶诱导剂,苯巴比妥使茶碱代谢率增加50%,主要为诱导细胞色素P-448酶系,苯妥英与氨茶碱并用10~15天后,可使茶碱清除率增加约2倍。此外,还发现茶碱能明显抑制苯妥英的吸收。

4.咖啡因^[3、6、7]通过竞争相同的酶系和受体而加速茶碱的清除,缩短半衰期。

5.卡马西平^[2]卡马西平能激活肝药酶,加速茶碱代谢和清除。

6.保泰松和甲磺丁脲^[2、8]它们均对肝药酶有诱导作用而使茶碱代谢加快,血药浓度降低。

7.硝苯吡啶^[2]它可使茶碱血药浓度下降,机制不明。

8.速尿^[8]可使利尿效应增强,茶碱清除加快。

9.巴比妥类^[8、13]巴比妥类可以加速茶碱代谢,使血药浓度下降。另据观察,用硫贲妥钠、鲁米那抢救小儿大剂量氨茶碱中毒,疗效肯定。

10.维生素C^[8、14]维生素C是强还原性和酸性物质,与氨茶碱合用影响溶液pH而使维生素C构向改变而失效,同时也使氨茶碱的解离度增大,不易被肾小管重吸收,排泄增加,血药浓度下降,故不能配伍使用。

三、不影响氨茶碱血药浓度的药物

1.青霉素^[3、5、15]青霉素为6-氨基青霉酸的衍生物,极易为碱分解而失活,与氨茶碱合用,因pH升高,使青霉素失活而降效。

2.庆大霉素^[3、5]氨茶碱注射液与庆大霉素合用,溶液可产生沉淀或浑浊。此外,氨茶碱的碱性使庆大霉素容易重吸收,抗菌效力增强,毒性加大。

3.呋喃咀啶^[3]呋喃咀啶在酸性条件下抗菌性强,氨茶碱可碱化尿液使其疗效降低。

4.去甲肾上腺素及肾上腺素^[3、5]氨茶

碱为碱性药,与前者配伍注射会很快失效。但也有认为在哮喘发作时,两药合用能加强止喘效果,且不增加不良反应。

5. 阿斯匹林^[5] 该药为弱酸性药,氨茶碱可使尿液碱化,而使阿斯匹林排泄加快,疗效降低。

6. β_2 -兴奋剂^[5、8、16] 氨茶碱加 β_2 -兴奋剂如:间羟喘宁、沙丁胺醇等,可协同提高细胞内cAMP水平,使平喘作用显著增强。两药小剂量或较大剂量合用均有相加作用。其中小剂量合用效果好,大剂量合用不良反应增加。

7. 异丙托品^[5、8、17] 两者合用有相加作用,比单用为佳,且不易产生耐药性。

8. 安泰乐、异丙嗪^[5、8] 氨茶碱与安泰乐、异丙嗪合用后,疗效明显增加,呈协同作用,且不良反应相应降低,疗效维持时间延长。但氨茶碱与异丙嗪不可混合使用,以免产生沉淀而影响疗效。

9. 麻黄素^[2、3、5、18] 二者合用后毒性增加。

10. 异博定^[8] 异博定完全取消氨茶碱增强膈肌收缩力的作用,如合用呼吸效应减弱。

11. 心得安^[8、9] 茶碱中毒后,血浆浓度与血糖升高,血钾降低有关,并用心得安可纠正低血钾及高血糖症,改善血流动力学,因此,心得安对茶碱中毒病人是有益的。

但心得安与氨茶碱配伍应用时应注意,由于心得安的 β -受体阻断作用降低了cAMP水平而拮抗氨茶碱的减少cAMP分解的作用,从而使哮喘症状得不到缓解。

12. 芬太尼^[8、19] 有报道,使用氨茶碱能对抗芬太尼的残存作用,减轻或解除后者的呼吸抑制作用。

13. 胃复安^[20] 据报道,支气管哮喘急性发作的患者,氨茶碱250mg加入50%葡萄糖

糖40ml,静脉推注同时肌注胃复安20mg,可在20分钟后缓解哮喘,同时能对抗氨茶碱的毒付作用。

14. 琥珀胆碱^[21] 据报道对一例单次静注琥珀胆碱呼吸抑制长达94分钟者,使用氨茶碱拮抗成功。

15. 潘生丁^[3] 氨茶碱对细胞内破坏环磷酸腺苷的磷酸二酯酶有抑制作用,从而提高了环磷酸腺苷含量而松弛平滑肌,扩张冠状动脉和支气管。潘生丁则通过抑制腺苷脱氨酶使腺苷降解变慢而促进冠状动脉扩张。应慎用。

参 考 文 献

- [1] 刘萱,等.红霉素和氨茶碱的相互作用.中国临床药理学杂志 1988; 4(4):218.
- [2] 梁钧鹤.氨茶碱的临床应用.新医学 1988; 19(4):208.
- [3] 陈顺烈,等.氨茶碱的药物相互作用.中国医院药理学杂志 1988; 8(10):441.
- [4] 袁青禄.氨茶碱的合理应用.临床医学 1988; 8(1):37.
- [5] 田海明.氨茶碱的合理应用.中级医刊 1987; 22(2):48.
- [6] 王铁英,等.氨茶碱中毒的临床表现及处理.中级医刊 1989; 24(10):44.
- [7] 孙忠实.氨茶碱的临床药理进展.中国医院药理学杂志 1987; 7(6):251.
- [8] 林才朱.氨茶碱药物的相互作用.中国医院药理学杂志 1990; 10(5):214.
- [9] 张海燕.茶碱与其它药物的相互作用.中国药理学杂志 1991; 26(1):46.
- [10] 傅德兴,等.新型诺酮类药物的不良反应及相互作用.中国药理学杂志 1990; 25(2):100.
- [11] 邓道济.抗痛风药别嘌呤醇的用药注意.中国医院药理学杂志 1991; 11(1):17.
- [12] 王金元.利福平与氨茶碱的相互作用.中国医院药理学杂志 1989; 9(9):404.
- [13] 张锐敏,等.巴比妥抢救小儿大剂量氨茶碱中毒分析.云南医药 1987; 8(3):161.
- [14] 周维书,等.抗坏血酸在几种混合输液中的稳定性.中国药理学杂志 1989; 24(5):288.
- [15] 赵向东.临床不合理用药30例分析.中级医刊 1988; 23(10):50.
- [16] 金克宁,等.沙丁胺醇对氨茶碱血药浓度及药动学参数的影响.中国医院药理学杂志 1989; 9(6):246.
- [17] 徐叔云,卞如瀛,主编.呼吸系统疾病的用药.临床药理学(下册)第一版.上海,上海科技出版社

1986;198~201.

〔18〕 丁祖锐,等.正常人氨茶碱与麻黄碱同服后药动学研究.中国药学杂志 1990; 25(10):587.

〔19〕 王明德,等.氨茶碱拮抗芬太尼的临床报告.中华麻醉学杂志 1987; 7(4):222.

〔20〕 李开明.胃复安对抗氨茶碱毒付作用的临床观察.临床内科杂志 1988; 5(4):11.

〔21〕 王明德.用氨茶碱治疗琥珀胆碱所致的呼吸抑制延长.湖南医学 1979; 4(4):276.

（卫生管理）

浅议医疗事故的认定

石油天然气管道局医院(102849)

丰爱华

医疗工作关系到每一个人的健康和生命,尽管医学科学已有飞跃的发展,但是由于种种原因,医疗事故仍难以完全避免,在医疗过程中,患者致死致残的现象时有发生,正确认定这类问题的性质,不仅直接关系到是否要追究当事人的法律责任,而且对于保障病人和医务人员的合法权益,维护医院的工作秩序,保证医疗工作的顺利进行,有着十分重要的意义。

本文试图就如何正确认定和区分医疗事故、医疗意外和故意伤害,谈谈自己的一些粗浅看法,请各位专家和读者指正。

一、医疗事故的本质是过失

国务院颁布的《医疗事故处理办法》第二条规定:“本办法所称的医疗事故是指在诊疗护理工作中,因医务人员诊疗护理过失,直接造成病员死亡、残废、组织器官损伤,导致功能障碍〔5〕”。因此医疗事故当事人主观上只能是过失,而不是故意。造成医疗事故的医务人员在主观上并不希望医疗事故的发生,而是对于自己的行为可能会造成的不良后果没有预见,或者虽有预见,但轻信这种后果可能不会发生〔1〕,是出于一种过失的心理状态。判断是否是医疗事故,首先必须确定当事人对事故的后果并无故意的企图,如果存在故意的企图,有意给病人造成某种伤害,即就不是医疗事故而是故意伤害、故意杀人了。如一案例,某医院管理不善,将砒霜标签丢失,而一药剂师凭自己的记忆将砒霜当芒硝发出,造成多人中毒、死亡〔2〕。这个案例中,药剂师没有企图投毒的动机,不是故意犯罪。但是作为药剂师应该完全知道发错药物将会造

成不良后果,甚至给病人带来生命危险。本应将没有标签的药物封存,他却轻信自己的记忆,认为发的是芒硝而不是别的药物,轻信不会发生不良后果,这就构成了过失犯罪。

二、医疗事故与医疗意外的区别

过失犯罪中,行为人对过失造成的后果是可以预见而没有预见或轻信可以避免,而不是不能预见,限于医学发展水平,若行为人不能预见,则是医疗意外,而不是过失了。某案例一患者因牙周感染到某医院就诊,护士按规定做青霉素皮试,皮试半分钟后,出现过敏反应,经抢救治疗无效死亡。事后调查药物质量、皮试液配制等正确,过敏发生后医护抢救及时,用药合理〔2〕。青霉素皮试过敏死亡极为罕见,虽有报导,但发生率极小,各国未因此而改变试敏的方法,因此,当属不可预见的医疗意外,而不是医疗事故。

三、医疗事故与技术事故的区别

由于主观方面的表现形式不同,医疗事故可以分为医疗事故和责任事故。责任事故是指医务人员因违反规章制度、诊疗护理常规等失职行为所致的事故。技术事故是指医务人员因技术过失所致〔5〕。这两类事故出现的原因虽都属于过失,违反了医疗规章制度或操作规程,但二者有明显不同〔4〕。责任事故是明知违反制度却轻信可以避免,技术事故则是由于行为人技术水平所限,不知道自己的行为已经违反了规章制度和操作规程。如某医院一外科医生,在为病人施行手术时,误将一把止血钳留在病人腹腔内,致使病人因绞窄性肠梗阻而死亡〔4〕。手术后应对器械物品做清点核